NUTROW

Return on Investment

Outil économique de l'analyse primaire de l'impact de l'utilisation de la plate-forme de Dim3

Dim3 a créé un tableau Excel qui permet d'avoir un ordre d'idée de l'impact d'une amélioration du processus interne de gestion de la nutrition clinique par l'utilisation de la plateforme digitale de Dim3 qui améliore transversalement le flux et la pertinence des données entre les différents départements impliqués.

Ce tableau a été validé notamment à l'hôpital Erasme (Dr Preiser , Mme Farine).

Composition plateforme digitale Dim3

Scorso : détection du risque de malnutrition envoyant données au DPI et/ou Scorso

Nutrow : A partir des données brutes issues des outils IT de l'institution : Création de tableaux de bord cliniques assurant un suivi documenté de la nutrition clinique pour la prescription et correctif de traitement nutritionnel. La compliance de nutrition clinique en est augmentée significativement

Feedim : Medical device captant les données brutes des appareillages médicaux , envoyées à Nutrow et assurant ainsi un suivi exact et en temps réel du fonctionnement de l'appareil et de l'adéquation entre le prescrit et le délivré.

Le tableau excel a été établi a partir des différents criteres relatifs à la gestion de la nutrition clinique dans un hopital. Il permet d'objectiver les situations au temps 0 , déterminer des objectifs et clarifier les KPI dans la gestion de la nutrition clinique.

PARTIE 1 : DONNEES GENERALES

Nutrow ROI Tool

Instructions: Modify the yellow cells only

Key Assumptions					
Hospital Inputs					
Hospital Stay		Malnutrition		HCP	
Inpatient admissions per year	43.000	Prevalence of at risk of malnutrition (%)	30%	Available FTE for NS	9
Average Length of Stay (days)	5,0	Prevalence of malnourished patients (%)	25%	Average cost per FTE	65.000
Average cost per hospitalized day (EUR)	600			Working days (annualy)	200
				Hours per working day for NS	6
Readmission (only if applicable)		ICD10/DRG coding (only if applicable)		Desired reach of NS	
Current readmission rate at 10 days [5]	3%	Malnutrition codes actually documented	15%	Patients screened	100%
		Additional revenue per day (EUR)	40	Targeted patients for NS	Malnourished only
				% of targeted patients on nutrition support	100%
				Desired NS visits during a hospital stay	3
				NS visits per day per FTE	12

La partie 1 du tableau, permet d'encoder les données de l'établissement et des données générales relative à la malnutrition.

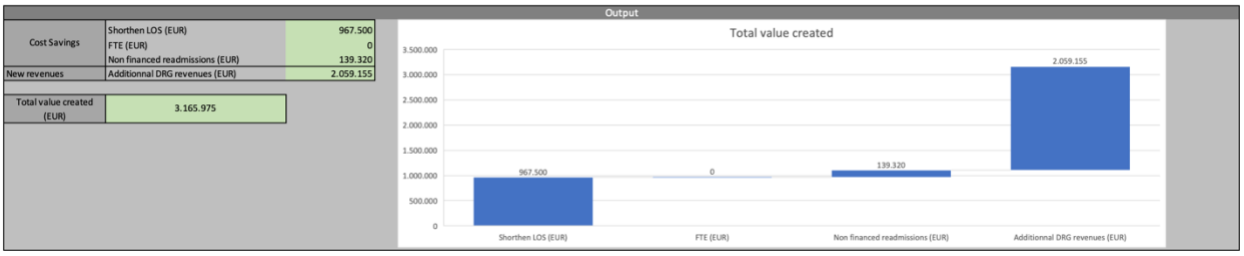
Y figure notamment le % de dossier patient ou le code malnutrition est encodé dans le RHM. Cette donnée nécessite une analyse préliminaire. Dans le cas Vivalia , elle a été effectuée par Vivalia avec un rapport émis le 5/12/22.

PARTIE 2 : DONNEES EXTERNES

Fixed Assumptions			
Effect of individualized nutritional support		Impact of Malnutrition	
Decreased LOS with NS	-3,0%	Increase on LOS	15%
Readmission at 10 days rate with NS	2,4%		
Workload without Nutrow		Workload with Nutrow	
Time spent on patient's file per visit (min)	9,70	Decrease patient's file management	-20%
		Time spent per patient's file per visit (min)	7,76

Cette partie du fichier reprend les données issues d'un consensus scientifiques ou de données présentes dans des peer review.

PARTIE 3 : RESUME



Cette partie du fichier permet de visualiser la création/perte de valeur théorique des choix quant à la gestion de la nutrition clinique.

Les impacts importants sont FTE et RHM. Les autres impacts sont des impacts dont la démonstration établissement par établissement nécessite une confirmation multi sources peut utilisable en Belgique.

PARTIE 4 : RESUME

Calculations (For Information Only)				
Hospital situation			Effect of NST	
Total hospital days per year	215.000		Actual days avoided with NS	-1.613
Well-nourished patients	32.250		Actual cost savings on LOS (EUR)	-967.500
Malnourished patients	10.750		Readmission (only if applicable)	
Average LOS well-nourished (wLOS)	4,79		Current yearly readmissions at 10 days	1.290
Average LOS malnourished (mLOS)	5,63	for	Total potential readmissions with NS	1.032
Well-nourished hospital days	154.437		Net avoided readmission at 10 days	258
Malnourished hospital days	60.563		Avoided readmission cost saving (EUR)	774.000
Maximum days saved if malnourished burden was fully alleviated	9.085		Non funded cost (18% in Belgium if within 10 days) (EUR)	139.320
Cost of extra days due to malnutrition (EUR)	5.450.704		ICD10 coding (only if applicable)	
NS Needs			Malnourished hospitalized days - Coded	9.085
Patients screened	43.000		Malnourished hospitalized days - Uncoded	51.479
At-risk patients	12.900			
Malnourished patients	10.750		Additionnal DRG revenues (EUR)	2.059.155
Patients on nutrition support	10.750			
Total NS visits required	32.250			
NST - Current situation			NST - Nutrow situation	
Total time (min) per NS visit - Current situation	30		Total time (min) per NS visit - Nutrow	28
NS visits per day per FTE - current situation	12		NS visits per day per FTE - with Nutrow	13
NST visits per FTE per year	2.400		NST visits per FTE per year - with Nutrow	2.566
Theorical NS visits with current ressources - with usual situation	21.600		Theorical NS visits with current ressources - with Nutrow	25.980
Gap - Resources vs Needs (NST visits)	-10.650		Gap - Resources vs Needs (NST visits)	-6.270
Gap - Resources vs Needs (NST visits)	-4,44		Gap - Resources vs Needs (NST visits)	-2,44
Savings or Investment required (EUR)	-288.438		Savings or Investment required (EUR)	

Cette partie du tableau génère les calculs plus précis en fonction des données globales introduites et indique les impacts de l'utilisation de Nutrow, l'élément central de la plateforme digitale Dim3